·专家共识·

广西眩晕中西医诊疗专家共识

广西医师协会中医脑病专业委员会
通信作者：古联，Email：gulian2012@163.com

【摘要】 头晕与眩晕是患者就诊最常见的病因与症状之一，尽管其并不危及生命，但与患者的生活质量、工作效率密切相关，更是许多疾病的早期预警信号。眩晕相关疾病存在诊治难度大、病情反复、迁延不愈等特点，中西医结合治疗眩晕有明显的优势。广西位于中国华南地区，地处低纬，北接南岭山地，岭南地处亚热带季风气候区，在地理环境、太阳辐射、大气环流等因素的共同作用下，形成了气候温暖、热量丰富、降水丰沛的气候特点，岭南炎热、潮湿、多雨的气候特点与痰湿、火热病证之间的关系密切，人群以湿热体质居多。目前，有关眩晕的中西医结合诊治指南、规范及共识较少，针对广西少数民族地区的区域性专家共识更少见。因此，结合广西地域、气候、人群体质特征、壮医特色诊疗技术等整理出符合广西地域情况的眩晕中西医诊疗专家共识，以期为该病的临床诊疗提供参考。

【关键词】 眩晕； 中西医； 诊断； 治疗； 专家共识
【DOI】10.3760/j.issn.1673-4777.2025.01.001 【中图分类号】R 441.2 【文献标识码】A

Expert consensus on diagnosis and treatment of vertigo in Guangxi based on traditional Chinese and western medicine

Traditional Chinese Medicine Encephalopathy Professional Committee of Guangxi Medical Doctor Association
Corresponding author: Gu Lian, Email: gulian2012@163.com

【Abstract】 Dizziness and vertigo are one of the most common causes and symptoms of patients seeking medical advice. Although they are not life-threatening, they are closely related to the quality of life and work efficiency of patients, and are also early warning signals for many diseases. Vertigo related diseases have the characteristics of high difficulty in diagnosis and treatment, recurrent conditions and persistent symptoms. The combination of traditional Chinese and western medicine has obvious advantages in treating this disease. Guangxi is located in South China. It is located in low latitudes, bordering the Nanling Mountain Mountains in the north, and the south of the Five Ridges is located in the subtropical monsoon climate zone. Under the combined effect of geographical environment, solar radiation, atmospheric circulation and other factors, it has formed the climate characteristics of warm climate, rich heat and abundant precipitation. The climate characteristics of hot, humid and rainy in the south of the Five Ridges are closely related to phlegm dampness, and fire heat syndrome. The majority of people are humid and hot. Currently, there are few guidelines, norms and consensus on the diagnosis and treatment of dizziness based on the combination of traditional Chinese and western medicine, and regional expert consensus targeting ethnic minority areas in Guangxi is even rarer. Therefore, combining with the geographical conditions, climate, physical characteristics of the population, and diagnosis and treatment techniques with Zhuang medical characteristics in Guangxi, an experts consensus in the diagnosis and treatment of dizziness based on traditional Chinese and western medicine, is compiled to provide reference for the clinical diagnosis and treatment of this disease. We have compiled an expert consensus on the diagnosis and treatment of vertigo in accordance with the geographical conditions of Guangxi, with a view to providing reference for the clinical diagnosis and treatment of the disease.

【Keywords】 Vertigo; Chinese medicine and western medicine; Diagnosis; Treatment; Expert consensus

Bárány 学会在 2009 年把前庭症状分类为眩晕、头晕、姿势性症状和前庭-视觉症状。眩晕是指没有自身运动时的旋转感或摆动感等运动幻觉，是由于人体对空间定位障碍而引起的一种综合征，是平衡障碍在患者大脑皮层内产生的主观反应。头晕是不平衡感的总称，其与眩晕的发病机制不一致，但有时是同一疾病在不同时期的两种表现。头晕与眩晕是患者就诊最常见的病因与症状之一，尽管其并不危及生命，但与患者的生活质量、工作效率密切相关，更是许多疾病的早期预警信号。世界各国眩晕的发病率在不断升高。美国眩晕及平衡障碍的年患病率为 14.8%，患病人数达 3 300 万[1]。德国的国家电话健康访问调查显示，德国成年居民一生中中度或重度头晕或眩晕的患病率为 29.5%[2]。国内目前缺乏大规模的人群流行病学资料，曾有研究基于流行病学调查资料报道，国内人群中眩晕的患病率为 0.5%，占住院患者的 6.7%[3]。根据江苏省≥10 岁人群的眩晕流行病学调查研究，眩晕的总体患病率为 4.1%，且眩晕患病率随年龄增加呈上升趋势[4]。作为临床上较为多见的一种综合病症，眩晕逐渐进入大众的视野。

眩晕是一类常见病、多发病，也是神经疾病相关科室患者就诊最常见的原因之一。2005 年 10 月至 2007 年 10 月广西中医药大学第一附属医院（广西中医医院）曾对引起眩晕的疾病进行全面系统的筛查，结果显示中医院神经内科眩晕患者中最常见的病因是耳石症，占 45.25%[5]。除了耳石症这类疾病能诊断明确且手法复位治疗效果显著以外，由于对前庭疾病相关诊疗技术的认识缺乏和设备不足等条件的限制，部分眩晕相关疾病有时甚至难以明确诊断，治疗上往往也缺

【引用本文】广西医师协会中医脑病专业委员会. 广西眩晕中西医诊疗专家共识[J]. 中国医药，2025，20(1)：1-6. DOI：10.3760/j.issn.1673-4777.2025.01.001.

中国知网 https://www.cnki.net

乏特效药物，多强调综合治疗，包括中西医药物、针刺及其他外治手段，但是药物治疗和外治仅能暂时缓解症状，并不能有效防止眩晕的再次发生。反复多次发作的眩晕给患者带来沉重的负担。因此目前迫切需要找到切实有效的眩晕诊治方法。

中医学认为眩即眼花，晕是头晕，二者常同时并见，故统称为“眩晕”。其病机为风、火、痰、虚、瘀引起清窍失养所致。早在《内经》中就有了关于眩晕病因病机的概念，认为眩晕属肝所主，与髓海不足、血虚、邪中等多种因素有关。《素问·至真要大论》认为“诸风掉眩，皆属于肝”，肝为风木之脏，主升主动，肝风刚劲，多以上扰清窍，痰浊中阻，肝风挟痰上升，以致痰阻脑络，清阳难升，清窍被蒙，以致眩晕不适《灵枢·大惑论》论述“髓海不足，则脑转耳鸣，胫酸眩冒”；《丹溪治法心要》中记载眩晕证属痰者多，认为无痰不作眩，该观点成为目前中医治疗眩晕的一项指导思想；张仲景《伤寒杂病论》中阐述了痰阻中焦，气机不畅，清阳不升，浊阴不降的病机，记载了运用化痰利水方治疗眩晕。可见中医对于眩晕的认识是长久而深远的。中医因其独特的整体观念和辨证论治思想，在眩晕的治疗中有独特的优势，尤其是对于全身疾病以及不明原因引起的眩晕患者，更能凸显出其优势。

广西位于中国华南地区，地处低纬，北接南岭山地，岭南地处亚热带季风气候区，在地理环境、太阳辐射、大气环流等因素的共同作用下，形成了气候温暖、热量丰富、降水丰沛的气候特点，岭南炎热、潮湿、多雨的气候特点与痰湿、火热病证之间的关系密切，人群以湿热体质居多。岭南地区患者眩晕中医证候分布应以痰、火相关的证型居多，而来自卢建辉[6]的研究也证实了这一分布特点，其研究发现痰浊上蒙证、肝阳上亢证为眩晕分布最多的证型，累计占比 86.54%。壮医药历史源远流长，是我国传统民族医学的重要组成部分，围绕广西地域气候特征及广西人群体质特点形成一套独特的理论体系，千百年来为维护广西人民的健康作出了不可磨灭的贡献。壮医药在眩晕方面的治疗亦发挥重要作用。既往研究表明壮医治疗眩晕以针刺为主，配合壮医药方效果较佳[7]。

眩晕相关疾病存在诊治难度大、病情反复、迁延不愈等特点，中西医结合治疗本病有明显的优势。目前，我国眩晕诊断与治疗指南主要有《眩晕诊治专家共识》[8]、《眩晕诊治多学科专家共识》[9]等，但有关眩晕的中西医结合诊治指南、规范及共识较少，针对广西少数民族地区的区域性专家共识更鲜有报道，因此，结合广西地域、气候、人群体质特征、壮医特色诊疗技术等整理出符合广西地域情况的眩晕中西医诊疗专家共识。

1　常见眩晕相关疾病分类

2015 年 Bárány 学会提出了国际前庭疾病分类的诊断框架和流程，包括 4 个层面划分：症状和体征（第一层）、综合征（第二层）、功能障碍及疾病（第三层 A）及发病机制（第三层 B）[10]，其中第二层综合征包括急性前庭综合征、发作性前庭综合征及慢性前庭综合征。对眩晕相关症状、疾病进行分类是眩晕诊治的前提和基础，在诊治眩晕相关疾病时应先进行识别与归类，常见眩晕相关疾病分类见表 1。

表 1　常见眩晕相关疾病分类及定位

分类	中枢性	周围性	其他
急性前庭综合征	小脑/脑干病变（梗死、出血）	前庭神经炎、突发性感音神经性聋伴眩晕、迷路炎	–
发作性前庭综合征	后循环短暂性脑缺血发作、前庭性偏头痛、发作性共济失调	良性阵发性位置性眩晕、梅尼埃病、前庭阵发症	–
慢性前庭综合征	前庭小脑共济失调、神经系统变性病	双侧前庭病、单侧前庭病变	持续性姿势-感知性头晕

注　“–”为无项目

2　眩晕相关疾病诊断流程

眩晕相关疾病的诊治涉及多学科，因此要对患者进行详细的病史采集、系统的体格检查及有针对性的辅助检查。病史采集，包括患者主要症状、发作形式、持续时间、诱发因素及发作频率等。体格检查方面除了对患者进行一般检查外，还要针对神经科、耳科、眼科等进行系统检查。根据病史特点及体格检查进一步针对性地完善相应的辅助检查。另外，还需四诊合参进行中医辨证、体质辨识等以指导下一步的中西医结合治疗。围绕病史采集、体格检查及辅助检查，本共识总结归纳并最终形成眩晕相关疾病中西医诊断流程，有助于疾病的明确诊断及指导后续治疗。见图 1。

3　常见眩晕相关疾病的诊治

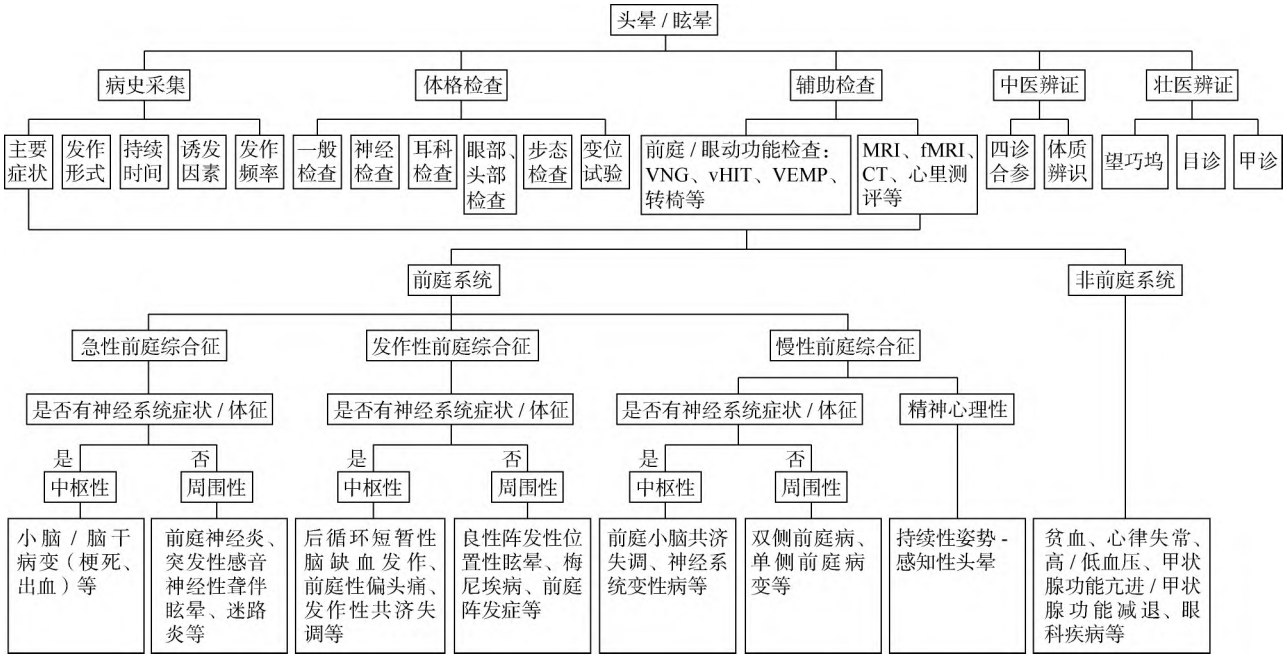
3.1　急性前庭综合征

3.1.1　小脑/脑干病变　小脑/脑干卒中，急性起病，临床表现为持续数小时至数天的眩晕，常合并局灶神经功能缺损，其症状可进一步总结为 6Ds：眩晕（Dizziness）、复视（Diplopia）、构音障碍（Dysarthria）、吞咽障碍（Dyphagia）、共济失调（Dystaxia）和跌倒发作（Drop Attack），体格检查可见不同类型的眼震，如垂直性眼震、凝视性眼震、单纯旋转性眼震、分离性眼震、中枢位置性眼震等。治疗可参考《中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018》[11]。针对中枢性急性前庭综合征患者要尽快完善相关影像学检查以便于进行鉴别诊断。

3.1.2　前庭神经炎　前庭神经炎常有前驱病毒感染史，临床表现为急性或亚急性眩晕发作，较严重的眩晕常持续 1～3 d，部分患者可持续 1 周左右，伴恶心、呕吐、震动幻视及身体不稳感，部分患者身体不稳感可持续数周，一般没有听力障碍。温度试验、视频头脉冲试验及前庭诱发肌源电位结果提示患侧前庭功能减退，有助于诊断及分型。部分前庭功能损害较严重的前庭神经炎患者身体不稳感可持续较长时间，注意与其他慢性头晕鉴别；前庭神经炎的最佳治疗方案是针对病因及对症治疗，可尽早使用糖皮质激素。

3.1.3　突发性感音神经性聋伴眩晕　突发性感音神经性聋的诊断标准：①与健侧或发病前对比，听力图中至少 2 个连续频段的听力下降大于或等于 20 dB 听力级的突发感音神经性耳聋，多为单侧，72 h 内达到高峰；②未发现明确病因；③可伴耳鸣、耳闷胀感、耳周皮肤感觉异常、眩晕、恶心及呕吐等。具体治疗可参考《突发性聋诊断和治疗指南（2015）》[12]。针对突发性感音神经性聋患者还应进一步完善磁共振成像检查，注意与桥小脑角肿瘤、桥臂脑梗死等中枢性疾病相鉴别；除改善微循环、高压氧等治疗手段，突发性感音神经性聋伴眩晕

中国知网　https://www.cnki.net



注：VNG 为视频眼震图；vHIT 为视频头脉冲试验；VEMP 为前庭诱发肌源电位；MRI 为磁共振成像；fMRI 为功能性 MRI

图 1　眩晕相关疾病中西医诊断流程图

应及早应用糖皮质激素。

3.2　发作性前庭综合征

3.2.1　后循环短暂性脑缺血发作　后循环短暂性脑缺血发作主要临床表现为头晕或眩晕、肢体无力、行走不稳、跌倒、肢体或头面部麻木、复视、短暂性意识丧失等，常见体征有肢体瘫痪、感觉异常、眼球运动障碍、共济失调、构音障碍、吞咽障碍、视野缺损等。典型临床症状持续时间 <1 h 且影像学检查无急性脑梗死的证据。但值得注意的是部分人频繁发作的后循环短暂性脑缺血发作可进展为脑梗死。后循环短暂性脑缺血发作的治疗可参考《中国短暂性脑缺血发作早期诊治指导规范》[13]。

3.2.2　前庭性偏头痛　前庭性偏头痛在眩晕相关疾病中占 6.7% ~11.2%[14]。前庭性偏头痛的诊断标准：①至少 5 次中度或重度的前庭症状发作，每次发作持续时间 5 min ~ 72 h；②依据国际头痛分类标准，现病史或既往史中存在无先兆偏头痛或有先兆偏头痛；③至少 50% 的前庭症状发作合并以下症状至少 1 项：头痛伴随以下症状至少 2 项（a 单侧、b 搏动性、c 中度或重度、d 日常体力活动加重头痛），畏声和畏光，视觉先兆；④不能用第三版国际头痛分类标准的其他诊断或其他前庭疾病更好地解释。除了①，另符合②或③，则应诊断为很可能的前庭性偏头痛。前庭性偏头痛的治疗可参考《前庭性偏头痛诊治专家共识（2018）》[15]。前庭性偏头痛应注意与梅尼埃病、良性阵发性位置性眩晕（BPPV）及精神源性眩晕/头晕相鉴别；对首次发作的患者或发作次数不足 5 次的患者应进行随访。

3.2.3　BPPV　BPPV 在眩晕相关疾病中占 17% ~30%[16]，BPPV 也称耳石症，临床表现为短暂的视物旋转/不稳，多发生在患者体位或头位改变的过程中，位置试验如 Dix-Hallpike Test、滚转试验等可观察到与症状同步出现的眼震[17]，手法复位是目前治疗 BPPV 的主要方法，后半规管 BPPV 的复位手法主要有 Epley 法、Semont 法，水平半规管 BPPV 复位手法有 Barbecu 法、Gufoni 法。多次复位效果欠佳或不能配合者可尝试 Brandt-Daroff 习服法；对于反复发作或手法复位后仍有残余症状的患者，可给予药物辅助治疗。

3.2.4　梅尼埃病　确定的梅尼埃病的诊断标准：①2 次或 2 次以上自发性眩晕发作，每次持续 20 min ~ 12 h；②至少有 1 次听力学检查证实患耳有低到中频的感音神经性聋；③患耳有波动性听力下降、耳鸣和/或耳闷胀感；④排除其他疾病引起的眩晕。可能的梅尼埃病诊断标准：①2 次或 2 次以上眩晕或发作性平衡障碍或空间定位障碍，每次持续 20 min ~ 24 h；②患耳有波动性听力下降、耳鸣和/或耳闷胀感；③排除其他疾病引起的眩晕。具体治疗可参考《梅尼埃病诊断和治疗指南（2017）》[18]。梅尼埃病应与伴随耳蜗症状的前庭性偏头痛及其他慢性头晕相鉴别，梅尼埃病目前多采取综合治疗手段，保守治疗无效时可考虑手术治疗。

3.2.5　前庭阵发症　前庭阵发症在眩晕相关疾病中占 3% ~ 4%[19]，确定的前庭阵发症诊断标准：①至少 10 次眩晕发作；②每次眩晕发作的持续时间 <1 min；③眩晕发作具有刻板性；④卡马西平或奥卡西平治疗有效；⑤不能归咎为其他疾病。可能的前庭阵发症诊断标准：①至少 5 次眩晕发作；②每次眩晕发作的持续时间 <5 min；③眩晕发作为一定头位诱发或自发性；④眩晕发作具有刻板性；⑤不能归咎为其他疾病。低剂量卡马西平或奥卡西平试验性治疗通常有效[20]。

3.3　慢性前庭综合征

3.3.1　双侧前庭病　双侧前庭病在眩晕相关疾病中占 4% ~ 10%[21]。双侧前庭病诊断标准：①具有下列症状的慢性前庭综合征（a 站立/行走不稳，并至少伴有以下 b 或 c 中的一项，b 行走或头部/身体快速运动时出现运动诱发的视物模糊/振动幻视，c 在地面不平或黑暗环境时不稳症状加重）；②静坐或平躺时症状消失；③前庭功能检查提示双侧角前庭眼动

中国知网 https://www.cnki.net

反射功能减退或缺失［满足其中 1 项：a 视频头脉冲试验双侧水平半规管前庭眼动反射增益 <0.6；b 冷热水试验每一侧眼震高峰的慢相角速度之和 <6°/s；c 正弦谐波转椅试验（0.1 Hz，最大角速度为 50°/s）水平增益 <0.1，相位超前 >68°（时间常数 <5 s）］；④不能归咎为其他疾病。可能的双侧前庭病诊断标准：①具有下列症状的慢性前庭综合征（a 行走/站立不稳，伴有以下 b 或 c 中的一项；b 行走或头部/身体快速运动时出现运动诱发的视物模糊/振动幻视；c 在地面不平或黑暗环境时不稳症状加重）；②静坐或平躺时症状消失；③甩头试验提示双侧水平半规管病变；④不能归咎为其他疾病[23]。双侧前庭病治疗主要采取前庭康复训练和针对原发疾病的治疗[23]。

3.3.2　持续性姿势-感知性头晕　持续性姿势-感知性头晕诊断标准：①大部分时间里存在头晕、不稳、非旋转性眩晕中的一种或多种症状，持续时间≥3 个月（a 症状持续时间长，常持续数小时，症状严重程度波动；b 症状在 1 d 内可不需持续 24 h）；②无明确的诱因，但以下 3 种情况可使症状加重（a 直立姿势，b 主动或被动运动，c 暴露于移动视觉刺激或复杂视觉环境）；③通常由引起头晕/眩晕的疾病所触发，包括急性/发作性/慢性前庭综合征，其他神经科、内科疾病以及精神心理疾病；④症状引起显著的焦虑或功能障碍；⑤症状不能由其他疾病或失调解释[24]。持续性姿势-感知性头晕主要采用前庭康复训练、心理治疗及药物治疗[25]。精神心理性头晕最早指一种躯体化形式障碍，包括持续性不稳感、失衡感或反复出现的头晕发作。关于精神心理性头晕的定义目前无统一意见，一般认为是无明确前庭功能障碍的慢性持续性头晕，但在诊断精神心理性头晕时应全面完善相关辅助检查排除可能存在的器质性疾病。

4　眩晕中医辨证论治

4.1　病因病机　眩晕可由风、火、痰、虚、瘀等多种原因引起。脑髓空虚，清窍失养，或痰火上逆，扰动清窍，或气血、肾精亏虚，脑髓失充，或痰浊阻遏、痰火气逆，上犯清窍而引起眩晕。眩晕发病过程中，各种病因病机可以相互影响，相互转化。眩晕病位在清窍，病变脏腑与肝、脾、肾三脏相关。肝郁化火，肝阳上亢，上扰头目，或肝阴不足，水不涵木，阳亢于上，发为眩晕；脾失健运，痰浊中阻，上扰轻窍，或脾气虚弱，气血亏虚，清窍失养，则发为眩晕。肾主骨生髓，肾精不足，髓海失充，亦可发为眩晕。眩晕病因繁多，简而言之其基本病理变化不外虚实两端，虚者由肝肾不足、气血不足、髓海空虚轻窍失养所致；实者则因痰浊中阻、肝阳上亢、瘀血阻络扰乱轻窍所致。

4.2　辨证分型　眩晕的临床证型较多，其病性有虚实两端。本共识将眩晕分为以下 5 个常见证型：痰湿中阻证、肝阳上亢证、气血亏虚证、瘀血阻窍证和肾精不足证。中医证型的诊断标准：符合症状、舌脉象即辨证成立。

4.2.1　痰湿中阻证

症状：头晕，视物旋转，胸闷，恶心呕吐等；舌脉象：舌苔白腻，脉濡滑。

治法：化痰祛湿，健脾和胃。

推荐方药：半夏白术天麻汤加减

组方举例：法半夏 10 g、陈皮 10 g、茯苓 10 g、白术 12 g、天麻 15 g、薏苡仁 20 g、竹茹 12 g、石菖蒲 12 g、生姜 6 g、甘草 6 g。

用法：3 剂，400 ml 水煎服，1 剂/d，分 2 次温服。

随症加减：腹胀、纳呆，可加砂仁、豆蔻等；恶心呕吐频繁，可加竹茹、代赭石等；耳鸣者，可加石菖蒲、郁金等。中成药可选用眩晕合剂（广西中医药大学第一附属医院），该合剂在该院脑病科临床应用多年，在半夏白术天麻汤的基础上，针对广西气候湿热特点，通过临床体质辨证加减而成。

4.2.2　肝阳上亢证

症状：头晕，视物旋转，耳鸣，头胀痛，口苦，面红，急躁易怒等；舌脉象：舌红苔黄，脉弦或数。

治法：平肝潜阳，清火熄风。

推荐方药：天麻钩藤饮加减

组方举例：天麻 15 g、钩藤 10 g（后下）、石决明 10 g（先煎）、川牛膝 9 g、杜仲 9 g、桑寄生 9 g、黄芩 9 g、山栀 9 g、夜交藤 10 g、茯神 10 g、益母草 10 g。

用法：3 剂，400 ml 水煎服，1 剂/d，分 2 次温服。

随症加减：头痛、耳聋、口苦目赤，可加龙胆草、桑叶、菊花等；便秘者，可加大黄、芒硝等；肢体麻木、震颤，可加僵蚕、地龙、全蝎等；心烦、失眠者，可加龙骨、牡蛎、珍珠母等。

4.2.3　气血亏虚证

症状：头晕，视物旋转，面白，乏力，心悸，失眠等；舌脉象：舌淡苔薄白，脉细弱。

治法：补益气血，调养心脾。

推荐方药：归脾汤加减

组方举例：黄芪 15 g、党参 12 g、白术 10 g、当归 10 g、茯神 10 g、龙眼肉 10 g、酸枣仁 10 g（打）、远志 12 g、木香 9 g（后下）、大枣 6 g、炙甘草 6 g。

用法：3 剂，400 ml 水煎服，1 剂/d，分 2 次温服。

随症加减：面色㿠白无华，加阿姣、熟地等；气虚自汗，可加防风、浮小麦等；便溏、泄泻者，可加薏苡仁、泽泻等；畏寒肢冷，加桂枝、干姜等。

4.2.4　瘀血阻窍证

症状：头晕，视物旋转，头痛，健忘，失眠，心悸，耳鸣，面唇紫暗等；舌脉象：舌暗有瘀斑或瘀点，脉涩或细涩。

治法：祛瘀生新，活血通窍。

推荐方药：通窍活血汤加减

组方举例：川芎 10 g、赤芍 15 g、桃仁 10 g（打）、红花 10 g、石菖蒲 10 g、白芷 10 g、当归 10 g、地龙 6 g、全蝎 6 g。

用法：3 剂，400 ml 水煎服，1 剂/d，分 2 次温服。

随症加减：气虚乏力者，可加黄芪以益气行血；若感寒，可加附子、桂枝；若当风，可加天麻、防风等。

4.2.5　肾精不足证

症状：头晕，视物旋转，腰膝酸软，健忘，失眠，耳鸣，遗精等；舌脉象：舌红苔薄，脉弦细。

治法：滋养肝肾，益精填髓。

推荐方药：左归丸加减

组方举例：熟地 10 g、山茱萸 12 g、山药 12 g、枸杞子 12 g、菟丝子 12 g、川牛膝 10 g、龟板胶 10 g（烊化）、阿胶 10 g（烊化）、酸枣仁 12 g、芡实 10 g。

用法：3 剂，400 ml 水煎服，1 剂/d，分 2 次温服。

随症加减：五心烦热者，可加知母、黄柏等；失眠多梦、健

中国知网　https://www.cnki.net

忘者,可加柏子仁、鸡子黄等。

随着人民活水平的提高,人们恣食肥甘厚腻以致脾失健运,痰浊内生,上扰清窍,可发为眩晕,临床上眩晕中医证型以痰浊中阻证居多;此外,考虑广西地域气候炎热潮湿的特征及人群湿热体质特点,因此在眩晕的临证治疗中应注重体质辨识,治疗上适当辅以清热祛湿功效的药物。

5 壮医特色外治疗法

眩晕壮医称为兰奔,多见于中老年人,常因情志不调,忧郁恼怒,气机不畅,两路不通,火毒内生,或饥饿劳倦,饮食不节,过食辛辣,损伤谷道,痰毒、火毒内生,上冲大脑,天地人三气不能同步而致。此外,病后虚弱,老年肾亏,气血不足,不能上养大脑,天地人三气不能同步,也可发生兰奔病症。

5.1 壮医药线点灸 选穴:四神聪、攒竹、头维、百会、风池、食魁、中魁、无魁。操作方法:①持线以右手拇指、食指夹持药线的一端,并露出线头 1 ~2 cm;②点火将露出的线端在煤油灯或其他灯上点燃,如有火焰必须扑灭,只需线头有火星即可;③施灸将线端火星对准穴位,顺应手腕和拇指屈曲动作,拇指指腹稳重而敏捷地将带有火星的线头直接点按在预先选好的穴位上,一按火灭即起为一壮,一般每次一个穴位灸一壮;④疗程:1 次/d,10 d 为 1 个疗程。

5.2 壮医经筋针刺 选穴:眶膈筋区、颞筋区、颈侧筋区、颈后筋区及肩背部经筋穴位,重点针对眶膈筋区的 1 ~7 穴位、颞前、颞后、颞筋膜、耳三肌及颈侧筋结点。操作方法:①先用指法在病变部位探查经筋线上的筋结点;②局部常规消毒,手持一次性针灸针,对准筋结点快速进针,不留针;③疗程:每个筋结点 2 min,1 次/d,7 d 为 1 个疗程。

5.3 壮医刮痧疗法 部位:头面部、颈肩部、上肢、下肢;操作顺序:先刮头面部,再刮颈肩部,最后刮四肢部;注意事项:手法宜轻柔,以出现痧斑为佳;疗程:隔天刮 1 次,7 次为 1 个疗程。

5.4 滚蛋疗法 操作方法:取煮好的温热蛋 2 只,趁热在头部、额部、颈肩部反复滚动热熨,直至微汗出;头部从印堂穴至神庭穴、从阳白穴至头维穴;颈肩部沿足少阳胆经,由风池穴至肩井穴;注意事项:滚蛋后,擦干汗液,嘱患者盖被静卧;疗程:1 次/d,7 d 为 1 个疗程。

6 结语

眩晕涉及的疾病多种多样,发病机制复杂,临床表现多变,眩晕的诊治涉及多学科问题,如前庭解剖及生理基础知识、神经系统、脑血管解剖及中枢前庭生理知识等,长期以来眩晕在国内外均存在着诊断困难、治疗不规范等问题。国内外专家及学者们对眩晕的研究仍不断取得可喜的进展。如何使眩晕疾病的诊疗规范化,更好地将中西医结合起来提高眩晕临床疗效,并将广西民族特色壮医药引入眩晕诊疗中,值得进一步探索和实践。

专家组组长 古联(广西中医药大学第一附属医院)
参与共识制定专家名单(按姓氏拼音顺序排列) 安红伟(柳州市中医医院);陈清(广西中医药大学第一附属医院);窦维华(广西中医药大学第一附属医院);古联(广西中医药大学第一附属医院);胡恕艳(广西中医药大学第一附属医院);黄勇华(广西中医药大学第一附属医院);蒋媛静(广西中医药大学附属瑞康医院);兰鹏(南宁市中医医院);梁宝云(广西中医药大学第一附属医院);林飞(广西中医药大学第一附属医院);林佳明(南宁市钦州市中医医院);刘永辉(广西中医药大学第一附属医院);陆岸英(南宁市宾阳县中医医院);陆春光(贵港市中医医院);罗宁(广西中医药大学附属瑞康医院);吕军(玉林市中医医院);吕军影(广西医科大学第一附属医院);秦昇(钦州市灵山县中医医院);谭凯文(南宁市中医医院);谭庆晶(广西中医药大学第一附属医院);王晋平(广西中医药大学第一附属医院);王凯华(广西国际壮医医院);吴鹏(广西中医药大学第一附属医院);徐守权(梧州市中医医院);薛伟新(贺州市中医医院);袁昌杰(河池市中医医院);张青萍(广西中医药大学第一附属医院);张永全(广西中医药大学附属瑞康医院);郑勇文(贵港市桂平市中医医院);周义杰(桂林市中医医院);祝美珍(广西中医药大学)
撰写人 梁宝云(广西中医药大学第一附属医院)
利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参考文献

[1] Kerber KA, Callaghan BC, Telian SA, et al. Dizziness symptom type prevalence and overlap: a US nationally representative survey [J]. Am J Med, 2017, 130(12): 1465. e1-1465. e9. DOI: 10.1016/j.amjmed.2017.05.048.

[2] Neuhauser HK, von Brevern M, Radtke A, et al. Epidemiology of vestibular vertigo: a neurotologic survey of the general population [J]. Neurology, 2005, 65(6): 898-904. DOI: 10.1212/01.wnl.0000175987.59991.3d.

[3] 周丽萍. 眩晕的流行病学调查研究[J]. 中国实用神经疾病杂志, 2010, 13(18): 31-32. DOI: 10.3969/j.issn.1673-5110.2010.18.016.
Zhou LP. Epidemiological investigation of vertigo [J]. Chinese Journal of Practical Nervous Diseases, 2010, 13(18): 31-32. DOI: 10.3969/j.issn.1673-5110.2010.18.016.

[4] 徐霞, 卜行宽, 邢光前, 等. 江苏省≥10 岁人群的眩晕流行病学调查研究[J]. 中华耳科学杂志, 2006, 4(4): 250-253. DOI: 10.3969/j.issn.1672-2922.2006.04.002.
Xu X, Bu XK, Xing GQ, et al. An epidemiologic study of vertigo in Jiangsu province [J]. Chinese Journal of Otology, 2006, 4(4): 250-253. DOI: 10.3969/j.issn.1672-2922.2006.04.002.

[5] 古联, 苏莉. 中医院神经内科眩晕患者的病因分析[J]. 广西医学, 2008, 30(11): 1771-1772. DOI: 10.3969/j.issn.0253-4304.2008.11.071.
Gu L, Su L. Etiological analysis of vertigo patients in neurology department of traditional Chinese medicine hospital [J]. Guangxi Medical Journal, 2008, 30(11): 1771-1772. DOI: 10.3969/j.issn.0253-4304.2008.11.071.

[6] 卢建辉. 中枢性眩晕的流行病学调查和中医证治规律研究[D]. 广州: 广州中医药大学, 2021.
Lu JH. Epidemiological investigation of central vertigo and study on traditional Chinese medicine syndrome and treatment rules [D]. Guangzhou: Guangzhou University of Chinese Medicine, 2021.

[7] 杨鑫勇, 王凯华, 刘丹宁, 等. 壮医在脑病科常见病中的应用进展[J]. 广西中医药, 2020, 43(6): 73-76. DOI: 10.3969/j.issn.1003-0719.2020.06.025.
Yang XY, Wang KH, Liu DN, et al. Progress in the application of Zhuang medicine in common diseases in the department of encephalopathy [J]. Guangxi Journal of Traditional Chinese Medicine, 2020, 43(6): 73-76. DOI: 10.3969/j.issn.1003-0719.2020.06.025.

[8] 中华医学会神经病学分会, 中华神经科杂志编辑委员会. 眩晕诊治专家共识[J]. 中华神经科杂志, 2010, 43(5): 369-374.

中国知网 https://www.cnki.net

DOI: 10.3760/cma.j.issn.1006-7876.2010.05.016.
Chinese Society of Neurology, Editorial Committee of the Chinese Journal of Neurology. Expert consensus on vertigo diagnosis and treatment [J]. Chinese Journal of Neurology, 2010, 43(5): 369-374. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1006-7876.2010.05.016.

[9] 中华医学会神经病学分会,中华神经科杂志编辑委员会. 眩晕诊治多学科专家共识 [J]. 中华神经科杂志, 2017, 50(11): 805-812. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1006-7876.2017.11.002.
Chinese Society of Neurology, Editorial Committee of the Chinese Journal of Neurology. Multidisciplinary expert consensus on vertigo diagnosis and treatment [J]. Chinese Journal of Neurology, 2017, 50(11): 805-812. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1006-7876.2017.11.002.

[10] isdorff AR, Staab JP, Newman-Toker DE. Overview of the international classification of vestibular disorders [J]. Neurol Clin, 2015, 33(3): 541-550. DOI: 10.1016/j.ncl.2015.04.010.

[11] 中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018 [J]. 中华神经科杂志, 2018, 51(9): 666-682. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1006-7876.2018.09.004.
Chinese Society of Neurology, Cerebrovascular Disease Group, Chinese Society of Neurology. Chinese guidelines for diagnosis and treatment of acute ischemic stroke 2018 [J]. Chinese Journal of Neurology, 2018, 51(9): 666-682. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1006-7876.2018.09.004.

[12] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会. 突发性聋诊断和治疗指南(2015) [J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2015, 50(6): 443-447. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-0860.2015.06.002.
Editorial Committee of the Chinese Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Otolaryngology Head and Neck Surgery Branch, Chinese Medical Association. Guidelines for the diagnosis and treatment of sudden deafness (2015) [J]. Chinese Journal of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, 2015, 50(6): 443-447. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-0860.2015.06.002.

[13] 国家卫生计生委脑卒中防治工程委员会. 中国短暂性脑缺血发作早期诊治指导规范 [S]. 北京: 国家卫生计生委脑卒中防治工程委员会, 2016.
Stroke Prevention and Treatment Engineering Committee of National Health and Family Planning Commission. Guidelines for early diagnosis and treatment of transient ischemic attack in China [S]. Beijing: Stroke Prevention and Treatment Engineering Committee of National Health and Family Planning Commission, 2016.

[14] Karatas M. Central vertigo and dizziness: epidemiology, differential diagnosis, and common causes [J]. Neurologist, 2008, 14(6): 355-364. DOI: 10.1097/NRL.0b013e31817533a3.

[15] 中国医师协会神经内科医师分会疼痛和感觉障碍学组,中国医药教育协会眩晕专业委员会,中国研究型医院学会头痛与感觉障碍专业委员会. 前庭性偏头痛诊治专家共识(2018) [J]. 中国疼痛医学杂志, 2018, 24(7): 481-488. DOI: 10.3969/j.issn.1006-9852.2018.07.001.
Pain and Sensory Disorders Group, Neurologist Branch, Chinese Medical Doctor Association, Vertigo Professional Committee, China Medical Education Association, Headache and Sensory Disorders Professional Committee, China Research Hospital Association. Expert consensus on the diagnosis and treatment of vestibular migraine (2018) [J]. Chinese Journal of Pain Medicine, 2018, 24(7): 481-488. DOI: 10.3969/j.issn.1006-9852.2018.07.001.

[16] Strupp M, Dieterich M, Brandt T. The treatment and natural course of peripheral and central vertigo [J]. Dtsch Arztebl Int, 2013, 110(29-30): 505-516. DOI: 10.3238/arztebl.2013.0505.

[17] Kim JS, Zee DS. Clinical practice. Benign paroxysmal positional vertigo [J]. N Engl J Med, 2014, 370(12): 1138-1147. DOI: 10.1056/NEJMcp1309481.

[18] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会. 梅尼埃病诊断和治疗指南(2017) [J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2017, 52(3): 167-172. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-0860.2017.03.002.
Editorial Committee of the Chinese Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Otolaryngology Head and Neck Surgery Branch, Chinese Medical Association. Guideline of diagnosis and treatment of Meniere disease(2017) [J]. Chinese Journal of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, 2017, 52(3): 167-172. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-0860.2017.03.002.

[19] Obermann M, Bock E, Sabev N, et al. Long-term outcome of vertigo and dizziness associated disorders following treatment in specialized tertiary care: the dizziness and vertigo registry(DiVeR) study [J]. J Neurol, 2015, 262(9): 2083-2091. DOI: 10.1007/s00415-015-7803-7.

[20] Strupp M, Lopez-Escamez JA, Kim JS, et al. Vestibular paroxysmia: diagnostic criteria [J]. J Vestib Res, 2016, 26(5-6): 409-415. DOI: 10.3233/VES-160589.

[21] Zingler VC, Cnyrim C, Jahn K, et al. Causative factors and epidemiology of bilateral vestibulopathy in 255 patients [J]. Ann Neurol, 2007, 61(6): 524-532. DOI: 10.1002/ana.21105.

[22] 凌霞,朱扬,王璟,等. 双侧前庭病诊断标准: Bárány 学会前庭疾病分类委员会共识 [J]. 神经损伤与功能重建, 2019, 14(12): 595-602. DOI: 10.16780/j.cnki.sjssgncj.2019.12.001.
Ling X, Zhu Y, Wang J, et al. Bilateral vestibulopathy: diagnostic criteria consensus document of the classification committee of the Bárány society [J]. Neural Injury and Functional Reconstruction, 2019, 14(12): 595-602. DOI: 10.16780/j.cnki.sjssgncj.2019.12.001.

[23] Zingler VC, Weintz E, Jahn K, et al. Follow-up of vestibular function in bilateral vestibulopathy [J]. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2008, 79(3): 284-288. DOI: 10.1136/jnnp.2007.122952.

[24] 李康之,刘博,Jeffrey P. Staab,等. 持续性姿势-感知性头晕(PPPD)诊断标准: Bárány 学会前庭疾病分类委员会共识 [J]. 神经损伤与功能重建, 2020, 15(2): 63-72. DOI: 10.16780/j.cnki.sjssgncj.2020.02.001.
Li KZ, Liu B, Staab JP, et al. Diagnostic criteria for persistent postural-perceptual dizziness(PPPD): consensus document of the committee for the classification of vestibular disorders of the Bárány society [J]. Neural Injury and Functional Reconstruction, 2020, 15(2): 63-72. DOI: 10.16780/j.cnki.sjssgncj.2020.02.001.

[25] Staab JP. Persistent postural-perceptual dizziness [J]. Semin Neurol, 2020, 40(1): 130-137. DOI: 10.1055/s-0039-3402736.

(收稿: 2023-03-28)
(本文编辑: 董帅)

中国知网 https://www.cnki.net